Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Augusto Pestana

Rua Venâncio Aires, 2470 - Bairro: Centro - CEP: 98740000 - Fone: (55)3029-9948 - Email: fraugupestvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000606-48.2025.8.21.0149/RS

AUTOR: MARIA HELENA SECCHI DE AVILA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

MARIA HELENA SECCHI DE AVILA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela antecipada, contra IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, ambos qualificados. Narrou a autora, em síntese, que é servidora pública aposentada, sendo conveniada junto ao requerido. Relatou que é portadora de Leucemia Mielóide Aguda evoluída de Síndrome Mielodisplásica (CID 10 C92.0) e, devido ao seu quadro clínico, sua médica lhe prescreveu o tratamento com o uso da medicação VENETOCLAX 100mg, na dose de 400mg diários. Sustentou que o não uso do medicamento prescrito pode acarretar no risco de morte. Disse que não possui condições de arcar com o custo do tratamento, uma vez que o valor total para o tratamento inicial de seis meses é de R$ 320.781,60. Sustentou que o requerido negou o fornecimento do referido fármaco, sob a alegação de que o medicamento não faz parte do rol de medicamentos disponibilizados pelo IPE. Discorreu sobre a legislação aplicável ao caso. Liminarmente, pediu a concessão do medicamento pleiteado. Por fim, requereu a procedência do pedido para confirmar a tutela de urgência, determinando que o requerido custeie o tratamento com uso do medicamento prescrito. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Indeferido o pedido de AJG e intimada a parte autora para recolher custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (evento 6, DESPADEC1).

Juntada guia de recolhimento das custas (evento 10, PET1).

Sobreveio aos autos Nota Técnica através do sistema e-NatJus (evento 14, NOTATEC1).

Recebida a inicial e deferida a tutela de urgência (evento 15, DESPADEC1).

O requerido informou o fornecimento do medicamento (evento 26, OFIC1).

Citado, o requerido apresentou contestação (evento 32, PET1). Aduziu, em suma, que o pedido não merece acolhimento, uma vez que a medicação solicitada pela parte autora não faz parte da cobertura para o tratamento da doença que lhe acomete. Sustentou que a concessão do tratamento pleiteado pela parte autora, que não se encontra autorizado pelas normas de assistência médica do Instituto, macula o princípio da legalidade. Defendeu, ainda, que não há como ser deferido o tratamento pleiteado, visto que a concessão infringiria as normas administrativas que regram a cobertura do Sistema IPE Saúde, subvertendo, por consequência, o equilíbrio financeiro que pressupõe a manutenção do sistema. Discorreu sobre a legislação aplicável ao caso. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Houve réplica (evento 39, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para dizer sobre as provas que pretendem produzir (evento 41, ATOORD1).

As partes postularam o julgamento do feito (evento 47, PET1 e evento 48, PET1).

Com vista, o Ministério Público declinou de intervir no feito (evento 53, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de demanda na qual a parte autora requer a condenação do requerido para o custeio de seu tratamento, uma vez que diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda evoluída de Síndrome Mielodisplásica (CID 10 C92.0), necessitando da medicação VENETOCLAX 100mg, na dose de 400mg diários.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 196 dispõe que: *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*.

No mesmo sentido, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

Na hipótese, de acordo com o atestado médico juntado ao evento evento 1, ATESTMED4, tem-se que a autora é portadora de Leucemia Mielóide Aguda evoluída de Síndrome Mielodisplásica (CID 10 C92.0). A médica que acompanha o seu tratamento prescreveu o uso do medicamento VENETOCLAX, na dose de 400mg por dia, assinalando o *"alto risco de óbito em caso de não uso da medicação venetoclax. A medicação venetoclax já está padronizada em primeira linha para este tipo de patologia",* destacando que *"o não uso da medicação venetoclax em associação com hipometilante (5 azacitidina) acarreta o maior risco de morbimortalidade"*, de forma que inviável a sua substituição por outro.

Aliado a isso, colaciono abaixo a conclusão da Nota Técnica do e-NatJus, juntada aos autos ao evento evento 14, NOTATEC1:

Conclusão

Tecnologia: VENETOCLAX

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Dados clínicos (laudo médico sumário) - exames acostados condizentes.
(...) portador sintomático para a patologia classificada sob CID 10 C92.0, Leucemia Mielóide Aguda evoluida de Sindrome Mielodisplasica, e encontra-se em tratamento quimioterápico com

a necessidade das medicações venetoclax (venclexta) associado a medicação e 5 azacitidina, tal patologia tem um alto risco de morte e tendo em vista que protocolos de quimioterapia standart tem maior toxicidade em pacientes acima de 60 anos ou com comorbidades associadas (considerado unfit) SOLICITADO PROTOCOLO VENETOCLAX + 5 AZACIDITINA pelo IPE, mas a medicação venetoclax não tem no rol do IPE, paciente de alto risco de óbito em caso de não uso da medicação venetoclax. A medicação venetoclax já está padronizada em primeira linha para este tipo de patologia vide referências bibliográficas NCC 1.2025 (clinical practice guidelines) o não uso da medicação venetoclax em associação com hipometilante (5 azacitidina) acarreta o maior risco de morbimortalidade
Vide NCCN 2025 National Comprehensive Cancer Network®INCCN®

Ademais, foi juntada ao feito a negativa administrativa do IPE-SAÚDE (evento 1, OUT6).

Destarte, as alegações da parte autora, corroboradas pela documentação anexa, notadamente os laudos médicos, devidamente fundamentados pela profissional habilitada que acompanha a autora, demonstram a imprescindibilidade do medicamento postulado.

Além disso, é importante destacar que a limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao seu paciente é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI).

É consabido que, em 06/04/2018, entrou em vigor a Lei Complementar n.º 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPÊ-Saúde, revogando a Lei Complementar n.º 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPÊ-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto. Veja-se:

> *Art. 4.º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1.º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*
>
> *§ 2.º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.*

Todavia, em que pese as disposições da nova lei, a ausência de previsão no protocolo oncológico não obsta o fornecimento do tratamento pleiteado, tendo em vista que devidamente comprovado pela parte autora a necessidade do medicamento preconizado pelo médico.

Desse modo, razão não há para que o requerido se negue a assegurar o tratamento e a intervenção mais adequada para a enfermidade da autora, a fim de assegurar-lhe o pleno direito à saúde. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS IPILIMUMABE E NIVOLUMABE PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. FÁRMACO FORA DOS PROTOCOLOS. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta pelo IPE-SAÚDE contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe, na dosagem e periodicidade determinadas pela médica assistente, para tratamento de neoplasia de rim com metástases ósseas na coluna cervical, pelve, tórax e púbis.* ***II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A questão em discussão consiste na obrigatoriedade do IPE-SAÚDE em fornecer medicamentos oncológicos não previstos em suas tabelas próprias, conforme a Lei Complementar nº 15.145/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR: A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Ao depois, as próprias Recomendações Técnicas em Oncologia do IPE-SAÚDE reconhecem que não têm como objetivo interferir na conduta médica ou autonomia profissional. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.*** *IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: LC nº 15.145/2018, art. 4º; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Resolução CFM nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min.*

Marco Buzzi, j. 17/12/2015; STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25/06/2019; TJRS, Apelação Cível nº 50069879420188210027, Rel. Ricardo Torres Hermann, j. 26/02/2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 52617031320248217000, Rel. Laura Louzada Jaccottet, Redator João Barcelos de Souza Junior, j. 26/02/2025. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51850086320248210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 18-09-2025) Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. 1. O FATO DE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODER SER CONCEDIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO EXONERA A PARTE INTERESSADA DA OBRIGAÇÃO DE, INSTADA JUDICIALMENTE, COMPROVAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. CASO EM QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS DEMONSTRAM QUE A PARTE AGRAVANTE POSSUI PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 2. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA, AO EFEITO DE SE DETERMINAR AO RÉU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DE QUE NECESSITA A DEMANDANTE. ***3. A RESPONSABILIDADE DO IPE SAÚDE EM FORNECER O FÁRMACO PRESCRITO À PARTE AUTORA ENCONTRA AMPARO NO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR 15.145/18, EM ESPECIAL NA PARTE EM QUE DISPÕE QUE INTEGRAM O PLANO IPE SAÚDE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, OS ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO, BEM COMO AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DOENÇA E À PROMOÇÃO DA SAÚDE. 4. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO À PATOLOGIA DA PACIENTE QUE COMPETE AO MÉDICO ASSISTENTE. ADEMAIS, CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, VEDADO QUE A ESCOLHA DO PROFISSIONAL A RESPEITO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO SEJA LIMITADA POR DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA OU REGIMENTAL DE HOSPITAL OU DE INSTITUIÇÃO, PÚBLICA OU PRIVADA.*** *5. INARREDÁVEL O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO DA DEMANDANTE SE NÃO FORNECIDO O FÁRMACO PRESCRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51619274020248217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 09-08-2024) (Grifei)*

Ademais, descabida a alegação do requerido no sentido de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas tabelas de cobertura vigentes, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Outrossim, inexistem provas nos autos que evidenciem qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo requerido ou que o tratamento postulado importaria oneração desnecessária.

De igual modo, não há que falar em afronta aos princípios da legalidade e isonomia, mesmo quando os medicamentos solicitados não integrem as tabelas de cobertura do plano de saúde, como é a hipótese dos autos. A propósito, colaciono a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53). NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2. A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado. 3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022)

Por conseguinte, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra razoável limitar as alternativas terapêuticas para o seu tratamento às listadas nas tabelas de coberturas que não conseguem acompanhar os avanços medicinais, pois, do contrário, se estaria colocando em risco seu direito constitucional à saúde.

Portanto, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento pleiteado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na exordial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA HELENA SECCHI DE AVILA para o fim de CONDENAR o IPE SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL a custear o tratamento com uso do medicamento VENETOCLAX 100mg, na dose de 400mg diários, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento, confirmando a tutela de urgência deferida ao evento 15, DESPADEC1.

Isento o requerido do pagamento da taxa única, com base no art. 5º, inciso I da Lei n. 14.634/2014). Contudo, condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 5º, parágrafo único, 14 e 16, todos da Lei n.º 14.634/2014), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade no patamar de R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada a intimação das partes.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 1.010, §1º, do CPC. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Após o transito em julgado, nada mais sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANDRÉ SIMM DE FAVERI, Juiz de Direito**, em 19/01/2026, às 18:36:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10098541065v4** e o código CRC **1e06d44a**.